



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 10 — Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) — adulto e criança

Diagnóstico, estratificação (CRB-65/CURB-65, critérios de gravidade ATS/IDSA), decisão de local de tratamento, antibiótico empírico por perfil, derrame parapneumônico, alta e transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-10	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A PAC é a principal causa de morte por doença infecciosa no Brasil e uma das três maiores causas de internação no SUS em idosos e em crianças <5 anos. As decisões do PS são três: **é pneumonia?** (40% dos diagnósticos clínicos sem imagem estão errados), **onde tratar?** (escore + juízo clínico + condições sociais) e **com o quê?** (esquema empírico por perfil de risco, iniciado em ≤ 4 h — ≤ 1 h se sepse, Protocolo 05). Este protocolo cobre adultos e traz seção pediátrica; pneumonia aspirativa, imunossuprimidos e tuberculose são tratados como exceções sinalizadas.

Fontes de ancoragem: Corrêa RA, Costa AN, Lundgren F, et al. *Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018*. J Bras Pneumol 2018;44(5):405-424 [SBPT 2018] (diretriz brasileira vigente; a de 2009 permanece como base); Metlay JP, et al. **Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: ATS/IDSA guideline**. Am J Respir Crit Care Med 2019;200:e45 [ATS/IDSA 2019]; Martin-Loeches I, et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe CAP. Eur Respir J 2023;61:2200735 [ERS 2023]; Dequin PF, et al. (CAPE COD) N Engl J Med 2023;388:1931 (hidrocortisona na PAC grave); Sociedade Brasileira de Pediatria. *Pneumonia adquirida na comunidade na infância* (Documento Científico, 2018/atualizações) e Diretrizes brasileiras em PAC em pediatria (J Bras Pneumol 2007) [SBP]; OMS. Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia (2014); Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde (SRAG/influenza) e PNI (vacinas).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; os esquemas empíricos devem ser validados pela CCIH conforme resistência local [VERIFICAR]. Itens [VERIFICAR]: POCUS, PCR/procalcitonina, teste rápido influenza/COVID, antígeno urinário, ceftriaxona/amoxicilina-clavulanato/azitromicina/levofloxacino em estoque.

1. Queixa — como o paciente chega

"Febre, tosse com catarro e dor nas costas/no peito para respirar" (dor pleurítica), "falta de ar", "calafrios", "cansaço". Idoso: frequentemente **sem febre e sem tosse** — "ficou confuso", "parou de comer", "caiu", "não é ele"; taquipneia é o sinal mais sensível. Criança: febre, tosse, "respiração rápida", "afunda a barriga/costela", gemência, recusa alimentar, dor abdominal (pneumonia de base). Perguntar: início e duração, escarro (cor, hemoptise), viagem, contato com aves/animais, tabagismo, álcool, DPOC/asma/IC/DM/DRC, imunossupressão (HIV, corticoide, quimioterapia, transplante), internação/antibiótico nos últimos 90 dias, vacinação (influenza, pneumococo, COVID), aspiração (disfagia, AVC, etilismo, rebaixamento), tosse >2-3 semanas/perda de peso/sudorese noturna (tuberculose — investigar sempre).

Padrões epidemiológicos que orientam o antibiótico

Contexto	Agentes a considerar
PAC típica sem comorbidade	<i>S. pneumoniae</i> (30–60%), <i>H. influenzae</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , vírus (influenza, VSR, SARS-CoV-2, rinovírus — 20–30%)
Idoso, DPOC, IC, DRC, DM, etilismo, asplenia, ILPI	Pneumococo (maior chance de resistência), <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i> , Gram-negativos entéricos, <i>S. aureus</i> , <i>Legionella</i>
Pós-influenza, cavitação, hemoptise, jovem grave	<i>S. aureus</i> (incluindo CA-MRSA), pneumococo
Internação ≥2 dias ou antibiótico IV nos últimos 90 dias, colonização prévia, bronquiectasias, traqueostomia, VEF ₁ <30%	<i>P. aeruginosa</i> , MRSA, enterobactérias resistentes
Aspiração (disfagia, AVC, etilismo, dentes em mau estado)	Anaeróbios só em abscesso/empiema/pneumonia necrotizante; aspiração comum: mesmos agentes da PAC
Contato com aves, roedores, gado, água estagnada, ar-condicionado	<i>Chlamydia psittaci</i> , hantavírus (região rural — SRAG), <i>Coxiella</i> , <i>Legionella</i>
Sazonal (março-agosto)	Influenza, VSR, COVID-19 — teste rápido e antiviral; notificar SRAG se internado

2. Clínica — diagnóstico, gravidade e local de tratamento

2.1 Diagnóstico [SBPT 2018; ATS/IDSA 2019]

Sintomas de infecção respiratória aguda (tosse, expectoração, dispneia, dor pleurítica, febre) + **sinais focais ao exame** (crepitações, sopro tubário, macicez, redução do MV) + **infiltrado novo à imagem** (RX ou USG/TC). A radiografia é recomendada em todo paciente atendido no PS (SBPT 2018): confirma, avalia extensão/derrame/cavitação e afasta diferenciais; POCUS tem sensibilidade ≥90% nas mãos de operador treinado e é útil em gestante, acamado e para derrame.

2.2 Estratificação — CRB-65 / CURB-65 [SBPT 2018 recomenda CRB-65 pela simplicidade]

Critério			Ponto	
C — Confusão mental (nova)			1	
U — Ureia >50 mg/dL (só no CURB-65)			1	
R — FR ≥30/min			1	
B — PAS <90 ou PAD ≤60 mmHg			1	
65 — Idade ≥65 anos			1	
CRB-65	Mortalidade aproximada	Local sugerido	CURB-65	Local sugerido
0	<1%	Ambulatorial	0–1	Ambulatorial
1–2	5–9%	Considerar observação/internação (1 = juízo clínico; 2 = internar)	2	Internação breve / observação
3–4	>20%	Internação urgente; avaliar UTI	3–5	Internação; UTI se 4–5

O escore não substitui o juízo clínico nem a avaliação social: SpO₂ <92% em ar ambiente, incapacidade de tomar medicação VO, comorbidade descompensada, derrame pleural significativo, cavitação, envolvimento multilobar, falha de tratamento ambulatorial, vômitos, ausência de suporte domiciliar, etilismo/uso de drogas, e psicossocial precário indicam internação mesmo com CRB-65 0–1 (SBPT 2018; ATS/IDSA 2019). Idade <65 anos com CRB-65 0 mas SpO₂ baixa = internar.

2.3 PAC grave — critérios ATS/IDSA (1 maior ou ≥3 menores = UTI)

Critérios maiores	Critérios menores
- Choque séptico com necessidade de vasopressor - Insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica	FR ≥30/min • PaO₂/FiO₂ ≤250 • Infiltrado multilobar • Confusão/desorientação • Ureia ≥43 mg/dL (BUN ≥20) • Leucócitos <4.000 • Plaquetas <100.000 • Temperatura <36 °C • Hipotensão exigindo reposição volêmica agressiva

2.4 Diferenciais

Condição	Pistas
Tuberculose pulmonar	Tosse $\geq 2-3$ semanas, sudorese noturna, emagrecimento, hemoptise, cavitação apical, contato, HIV, ILPI/prisão — pedir baciloscopia/TRM-TB antes de quinolona (mascara TB)
IC / EAP	Ortopneia, edema, congestão bilateral, BNP; pode coexistir
TEP com infarto pulmonar	Dor pleurítica, hemoptise, hipoxemia desproporcional, TVP, infiltrado periférico em cunha
Exacerbação de DPOC/asma sem consolidação	Protocolos 16/07
COVID-19 / influenza / SRAG viral	Infiltrado intersticial bilateral, mialgia, anosmia; teste rápido; notificar
Aspiração química, atelectasia, neoplasia, pneumonite por hipersensibilidade/fármacos (amiodarona, nitrofurantoína), vasculite, hemorragia alveolar	Contexto, evolução, resposta ao ATB
Abdome agudo em criança / apendicite	Pneumonia de base pode causar dor abdominal — e vice-versa

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
FR contada por 1 min , SpO ₂ em ar ambiente	FR ≥ 30 (adulto) = CRB-65; SpO ₂ $< 92\%$ = internar; criança: taquipneia por idade (OMS: < 2 m ≥ 60 ; 2-11 m ≥ 50 ; 1-5 a ≥ 40)
Consciência, orientação	Confusão nova = CRB-65 e sinal de sepse
PA, FC, TEC, temperatura	Hipotensão/hipoperfusão → Protocolo 05; hipotermia = gravidade
Ausulta e percussão	Crepitações localizadas, sopro tubário, broncofonia, macicez (consolidação/derrame); MV abolido em base com macicez = derrame → USG/RX em decúbito lateral
Tiragem, batimento de asa nasal, gemência (criança)	Pneumonia grave (OMS)
Estado de hidratação, capacidade de deglutir	Decide via oral x IV
Dentição, disfagia, sinais de etilismo	Aspiração/abscesso
Pele e mucosas	Herpes labial (pneumococo), lesões cutâneas (varicela, MRSA), palidez
Sinais de foco alternativo	Otite/sinusite, meningismo, ITU, celulite

4. Propedêutica armada [SBPT 2018; ATS/IDSA 2019]

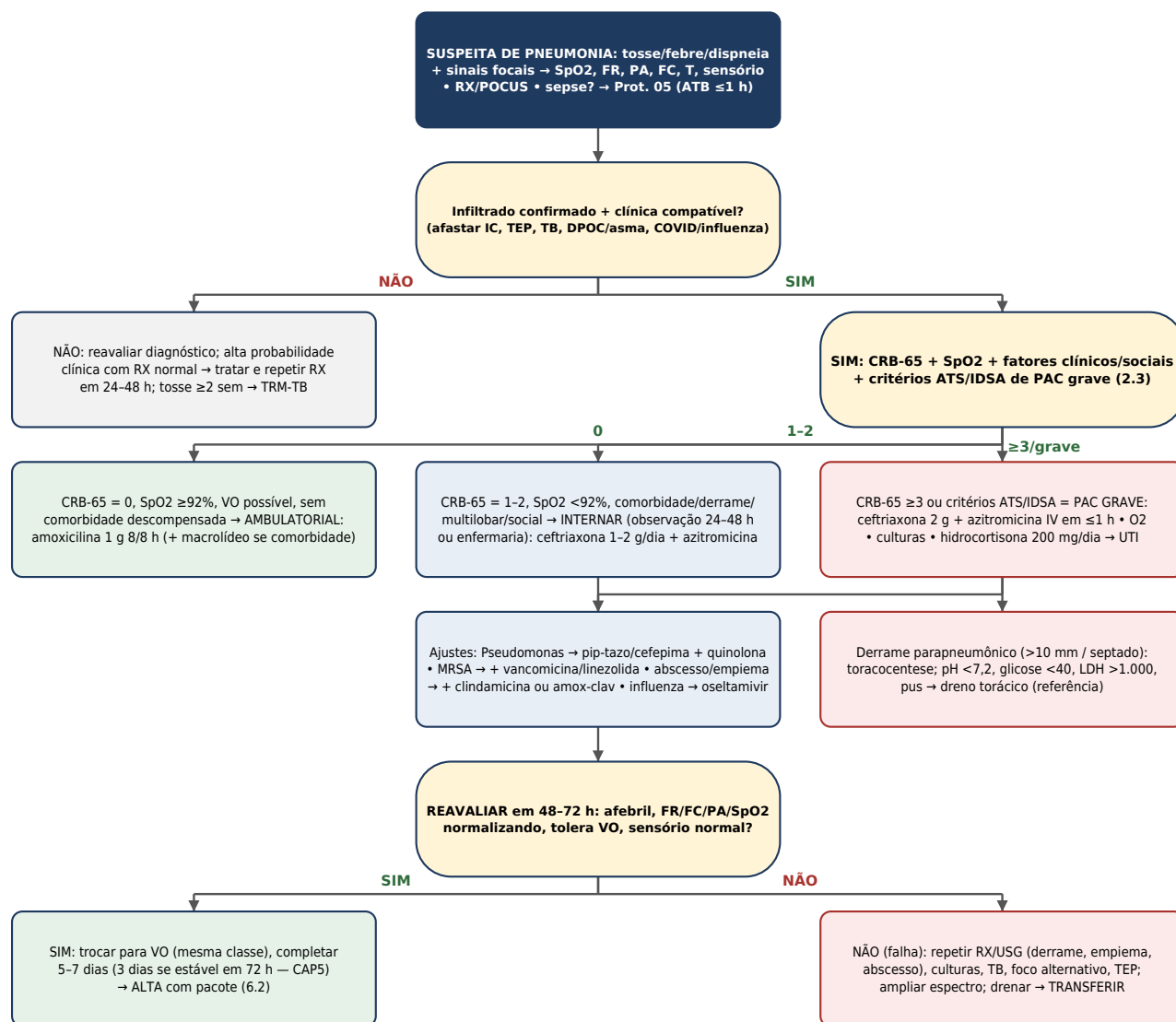
Exame	Para que serve	Quando
Radiografia de tórax (PA + perfil)	Confirma infiltrado; extensão (multilobar), derrame, cavitação, pneumotórax; controle só em 6 semanas se >50 anos/tabagista/sem resolução clínica	Todos no PS; repetir se piora
POCUS pulmonar	Consolidação com broncograma, derrame (volume, septos), alternativa ao RX	Se disponível/treinado [VERIFICAR]
Oximetria; gasometria arterial	Hipoxemia; $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$ (grave); hipercapnia	$\text{SpO}_2 < 92\%$, DPOC, sinais de gravidade
Hemograma, ureia/creatinina, eletrólitos, glicemia, TGO/TGP, lactato	Ureia (CURB-65), leucopenia/plaquetopenia (grave), LRA, lactato (sepse)	Todo paciente com indicação de internação
PCR ($\pm$ procalcitonina)	Apoio diagnóstico e de duração; PCR <20 mg/L torna PAC bacteriana improvável; não decidem iniciar ATB em PAC confirmada por imagem	Se disponível [VERIFICAR]
Hemoculturas (2)	Só em PAC grave, cavitação, derrame, imunossuprimido, asplenia, etilismo, falha ambulatorial — antes do ATB, sem atrasá-lo	Internados graves
Escarro (Gram + cultura; baciloscopia/TRM-TB)	Direciona/descalona; TB em tosse ≥ 2 semanas ou padrão sugestivo	Internados com escarro purulento; TB conforme suspeita
Antígeno urinário (pneumococo, <i>Legionella</i>)	Direciona ATB na grave	PAC grave, se disponível [VERIFICAR]
Teste rápido / PCR para influenza, COVID-19, VSR	Muda antiviral, isolamento e notificação (SRAG)	Sazonal; todo internado
Toracocentese diagnóstica	Derrame >10 mm em decúbito lateral ou septado: pH <7,2, glicose <40, LDH >1.000, pus ou bactéria = drenar	Derrame significativo — geralmente na referência
TC de tórax	Dúvida diagnóstica, imunossuprimido, complicação (abscesso, empiema), falha de tratamento	Selecionado (transferir se necessário)
Sorologia HIV	Recomendada em todo internado por PAC	Internados

5. Fisiopatologia

A PAC resulta da chegada de microrganismos ao alvéolo — por **microaspiração** de secreção orofaríngea colonizada (mecanismo principal para pneumococo, *H. influenzae*, anaeróbios), por **inalação de aerossóis** (vírus, *Mycoplasma*, *Legionella*, TB) ou, raramente, por via hematogênica (*S. aureus*). A infecção se estabelece quando a carga supera as defesas (tosse, muco-ciliar, macrófagos alveolares, IgA) — deprimidas por idade, tabagismo, álcool, infecção viral prévia (a influenza destrói o epitélio e abre caminho para pneumococo e *S. aureus*), diabetes, DPOC, imunossupressão. A resposta inflamatória enche o alvéolo de exsudato (consolidação: crepitações, sopro tubário, infiltrado), gera shunt e hipoxemia, e pode extravasar para a pleura (derrame parapneumônico → empiema quando invadido por bactérias). A resposta sistêmica desregulada é a sepse (Protocolo 05); em idosos, a resposta atenuada explica a ausência de febre e a apresentação por confusão. A cavitação e a necrose sugerem *S. aureus*, *Klebsiella*, anaeróbios ou TB. A mortalidade é determinada sobretudo pelo **tempo até o antibiótico**, pela gravidade fisiológica na chegada e pelas comorbidades — daí a lógica do score e do tratamento precoce.

6. Fluxo de atendimento [SBPT 2018; ATS/IDSA 2019, adaptado]

Confirmar → estratificar → tratar em ≤4 h (≤1 h se sepse) → reavaliar em 48–72 h. O escore decide o local; o juízo clínico e a situação social podem elevar, nunca rebaixar, o nível de cuidado.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Triagem → SpO ₂ , FR e classificação de risco	≤15 min
Chegada → radiografia laudada (ou POCUS)	≤1-2 h
Diagnóstico → 1ª dose de antibiótico	≤4 h (internados); ≤1 h se sepse/PAC grave
Reavaliação estruturada	24 h e 48-72 h (troca IV → VO)
Decisão de transferência (grave / falha / derrame complicado)	≤2 h do reconhecimento

6.2 Critérios de alta e pacote de alta [SBPT 2018; ATS/IDSA 2019]

Critérios de estabilidade clínica (todos, por ≥ 24 h)	Pacote obrigatório
• $T \leq 37,8$ °C • $FC \leq 100$ • $FR \leq 24$ • $PAS \geq 90$ • $SpO_2 \geq 90\%$ em ar ambiente (ou no O_2 basal) • Deglute e tolera VO • Sensório normal (ou basal) • Sem complicação não resolvida (derrame complicado, abscesso) • Comorbidades compensadas; suporte domiciliar; acesso ao retorno	• Antibiótico VO até completar 5-7 dias (mínimo 5 e ≥ 48 h de estabilidade; 3 dias se estável em 72 h — CAP5/ATS); 7-14 dias se <i>S. aureus</i>, <i>Pseudomonas</i>, abscesso/empiema, <i>Legionella</i> • Orientação de sinais de piora e retorno; repouso; hidratação; antitérmico • Retorno na UBS em ≤ 7 dias (idoso/comorbidade: 48-72 h) • RX de controle em 6-8 semanas se >50 anos, tabagista, ou sintomas persistentes (neoplasia oculta) • Vacinas: influenza anual; pneumocócica (PPSV23/PCV13 — ≥ 60 anos, comorbidades, via CRIE); COVID-19; VSR (≥ 60 anos) • Cessação do tabagismo; avaliar disfagia/aspiração; encaminhar HIV se positivo; notificar SRAG se internado com critério

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Antibiótico empírico — adulto [SBPT 2018; ATS/IDSA 2019] [VERIFICAR com CCIH e resistência local]

Perfil	Esquema preferencial	Alternativas / observações
Ambulatorial, sem comorbidade, sem ATB ≤3 meses	Amoxicilina 1 g VO 8/8 h (SBPT/ATS) por 5–7 dias; ou amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12 h	Alergia: azitromicina 500 mg/dia (resistência do pneumococo a macrolídeo >25% em SP — evitar isolado se possível) ou doxiciclina 100 mg 12/12 h; claritromicina 500 mg 12/12 h
Ambulatorial com comorbidade (DPOC, IC, DM, DRC, hepatopatia, etilismo, asplenia, neoplasia) ou ATB ≤3 meses	Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12 h + azitromicina 500 mg/dia (ou claritromicina) por 5–7 dias	Levofloxacino 750 mg/dia ou moxifloxacino 400 mg/dia (monoterapia) — reservar (QT, tendão, TB mascarada, resistência)
Internado, não grave	Ceftriaxona 1–2 g IV 1×/dia + azitromicina 500 mg IV/VO 1×/dia (ou claritromicina 500 mg IV 12/12 h)	Ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h + macrolídeo; alergia a betalactâmico: levofloxacino 750 mg IV/dia. Trocar para VO em 48–72 h de estabilidade (amoxicilina-clavulanato + azitromicina, ou levofloxacino)
PAC grave (UTI)	Ceftriaxona 2 g IV/dia + azitromicina 500 mg IV/dia (betalactâmico + macrolídeo é superior a quinolona na grave — ERS 2023); ou ceftriaxona + levofloxacino 750 mg IV	1ª dose em ≤1 h; hemoculturas, antígenos urinários; transferir
Risco de <i>Pseudomonas</i>	Piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h ou cefepima 2 g 8/8 h (ou meropenem 1 g 8/8 h) + levofloxacino 750 mg/dia ou azitromicina	Culturas antes; descalonar em 48–72 h
Risco de MRSA (pós-influenza grave, cavitação, colonização, ATB IV recente)	+ Vancomicina (ataque 25–30 mg/kg, depois 15–20 mg/kg 12/12 h) ou linezolida 600 mg 12/12 h	Suspender se cultura/PCR nasal negativa
Aspiração com abscesso, empiema ou pneumonia necrotizante	Amoxicilina-clavulanato ou ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h; ou ceftriaxona + clindamicina 600 mg 8/8 h	Aspiração sem essas complicações: não acrescentar cobertura anaeróbia de rotina (ATS/IDSA 2019)
Influenza suspeita/confirmada	Oseltamivir 75 mg VO 12/12 h por 5 dias (criança por peso), iniciar mesmo após 48 h se internado/grave; manter ATB até excluir coinfeção bacteriana	Notificar SRAG; isolamento
COVID-19 com pneumonia hipoxêmica	Dexametasona 6 mg/dia por até 10 dias (se O ₂); anticoagulação profilática; ATB só se coinfeção	Conforme protocolo vigente do MS

7.2 Terapia adjuvante

Medida	Conduta
Oxigênio	Se SpO ₂ <92% (88-92% no DPOC); alto fluxo nasal/VNI na hipoxemia grave enquanto transfere; IOT se falha
Corticoide	PAC grave (critérios ATS/IDSA / UTI) sem influenza/TB/fungo: hidrocortisona 200 mg/dia IV (50 mg 6/6 h ou infusão) por 4-8 dias com desmame (CAPE COD 2023: ↓ mortalidade; ERS 2023: recomendação); não na PAC não grave
Fluidos	Reposição guiada por perfusão (Protocolo 05); evitar hiper-hidratação
Analgesia/antitêrmico	Dipirona/paracetamol; dor pleurítica limita a tosse e a ventilação
Profilaxia de TEV	Enoxaparina 40 mg SC 1×/dia em internados
Fisioterapia/mobilização	Deambulação precoce; higiene brônquica se hipersecreção
Broncodilatador	Só se sibilância/DPOC/asma associados
Nutrição, glicemia, disfagia	Avaliar deglutição antes de liberar dieta em idoso/AVC; alvo glicêmico 140-180

7.3 Pediatria — PAC em ≥2 meses [SBP; OMS 2014; dose lock: conferir mg/kg antes de prescrever]

Classificação (OMS/SBP)	Critérios	Conduta
Pneumonia (não grave)	Tosse/dificuldade respiratória + taquipneia por idade (2-11 m ≥50; 1-5 a ≥40; >5 a ≥30-20) sem sinais de gravidade	Amoxicilina 50 mg/kg/dia VO 12/12 h (até 90 mg/kg/dia) por 5-7 dias ; retorno em 48 h; alergia: macrolídeo; ≥5 anos com padrão atípico: azitromicina 10 mg/kg/dia 3-5 dias
Pneumonia grave	Tiragem subcostal, gemência, batimento de asa nasal, SpO ₂ <92%, cianose, incapaz de beber/mamar, vômitos, letargia, convulsão, <2 meses com qualquer pneumonia	Internar: ampicilina 200 mg/kg/dia IV 6/6 h ou penicilina cristalina 200.000 UI/kg/dia; ceftriaxona 50-100 mg/kg/dia se falha/grave; + oxacilina 200 mg/kg/dia se pneumatocele/derrame/pós-varicela (<i>S. aureus</i>); O ₂ se SpO ₂ <92%; transferir para pediatria
Muito grave / choque / SpO ₂ <90% apesar de O ₂	Sinais de sepse, insuficiência respiratória	Protocolo 05 pediátrico; ceftriaxona + oxacilina/vancomicina; UTI pediátrica
Derrame pleural na criança	USG; toracocentese	Empiema → drenagem na referência; ATB IV prolongado
<2 meses	Qualquer suspeita	Internar: ampicilina + gentamicina (ou cefotaxima); considerar sepse neonatal — referência

Bronquiolite (<2 anos, sibilância viral): sem antibiótico nem broncodilatador de rotina — Protocolo 06. Vacinação (PCV10/13, Hib, influenza, pertussis) reduz PAC grave; conferir cartão na alta.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
PAC grave (critérios ATS/IDSA), choque, $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$, necessidade de VNI/IOT	Imediata (ATB antes de sair)	UTI
Derrame complicado/empiema, abscesso, pneumonia necrotizante, cavitação com hemoptise	Mesmo dia	Referência com cirurgia torácica/drenagem
CRB-65 1-2 ou hipoxemia sem estrutura de observação 24-48 h no PS	Mesmo dia	Enfermaria de referência
Criança com pneumonia grave, <2 meses, gestante com PAC hipoxêmica, imunossuprimido	Imediata / mesmo dia	Pediatria / obstetrícia / infectologia de referência
Falha ambulatorial em 48-72 h	Reavaliar no PS: RX, exames, internar	Conforme gravidade

8.2 Transporte e documentação

- USA/USB conforme gravidade; O_2 titulado; monitor se grave; isolamento respiratório se influenza/COVID/TB suspeita (máscara cirúrgica no paciente, N95 na equipe se TB).
- Relatório: CRB-65/critérios de gravidade, $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$, RX (imagem em mídia/laudo), **antibiótico com dose e hora da 1ª dose**, culturas colhidas, testes virais, comorbidades, vacinas, suspeita de TB (isolamento).
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica**; pediatria/cirúrgico/obstétrico: **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 Vigilância e notificação

- **SRAG** (síndrome gripal + dispneia/ $\text{SpO}_2 < 95\%$ /desconforto/hipotensão, internado ou óbito): notificação imediata no SIVEP-Gripe com coleta de swab (influenza, SARS-CoV-2, VSR).
- **Tuberculose**: notificação compulsória ao confirmar; iniciar investigação no PS (baciloscopia/TRM-TB) e encaminhar à UBS para tratamento.
- Surto (≥ 2 casos vinculados em ILPI/escola/instituição): comunicar a vigilância municipal.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com SpO_2 , FR e CRB-65 registrados na admissão	100%
% com radiografia (ou POCUS) documentada antes do antibiótico ou em ≤ 2 h	$\geq 90\%$
% de internados com 1ª dose de ATB em ≤ 4 h (≤ 1 h se sepse)	$\geq 90\%$
% de esquemas conformes ao protocolo (ou desvio justificado)	$\geq 85\%$
% com troca IV→VO documentada em 48-72 h de estabilidade e duração total ≤ 7 dias (não complicada)	$\geq 80\%$
% de internados com teste viral sazonal e notificação de SRAG quando indicada	$\geq 90\%$
% de altas com vacinas verificadas/encaminhadas e retorno ≤ 7 dias	$\geq 80\%$
Quinolona como 1ª escolha sem justificativa; ATB em bronquiolite/viral sem consolidação (eventos sentinela)	0
Retorno ao PS/reinternação em 30 dias; letalidade intra-hospitalar	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Diretriz brasileira	SBPT 2018 (recomendações) é a vigente, sem atualização posterior; ATS/IDSA 2019 e ERS 2023 (grave) complementam
Escore	SBPT recomenda CRB-65 pela simplicidade; ATS/IDSA prefere PSI/CURB-65. Adotado CRB-65 + juízo clínico + critérios ATS/IDSA de gravidade
Ambulatorial sem comorbidade	SBPT 2018: amoxicilina ou macrolídeo; ATS/IDSA 2019: amoxicilina 1 g 8/8 h preferida (resistência a macrolídeo). Adotada amoxicilina
Internado não grave	SBPT: betalactâmico + macrolídeo ou quinolona; ATS/IDSA idem. Adotada a combinação; quinolona reservada
Corticoide na PAC grave	CAPE COD 2023 e ERS 2023 recomendam hidrocortisona; ATS/IDSA 2019 (pré-CAPE COD) não. Adotada na grave sem influenza
Duração	SBPT: 5-7 dias; ATS/IDSA: ≥ 5 dias + 48 h de estabilidade; CAP5 (2021): 3 dias se estável em 72 h. Adotado 5-7 (3 se estável precoce e não complicada)
Cobertura anaeróbia na aspiração	ATS/IDSA 2019: só com abscesso/empiema; prática antiga: clindamicina de rotina. Adotada a restrição
Pediatria — doses	SBP/OMS: amoxicilina 50-90 mg/kg/dia; ampicilina 200 mg/kg/dia. Sujeitas ao dose lock institucional [VERIFICAR com o Protocolo de Pediatria]
Antígeno urinário, procalcitonina, POCUS, testes virais	Disponibilidade [VERIFICAR]
Resistência local (pneumococo a macrolídeo/penicilina)	Dados da CCIH/LACEN [VERIFICAR]

10. Referências

- Corrêa RA, Costa AN, Lundgren F, et al. Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J Bras Pneumol 2018;44(5):405-424. Corrêa RA, et al. Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes – 2009. J Bras Pneumol 2009;35(6):574-601.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia: an official clinical practice guideline of the ATS and IDSA. Am J Respir Crit Care Med 2019;200(7):e45-e67.
- Martin-Loeches I, Torres A, Nagavci B, et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2023;61(4):2200735.
- Dequin PF, Meziani F, Quenot JP, et al. Hydrocortisone in severe community-acquired pneumonia (CAPE COD). N Engl J Med 2023;388:1931-1941. Dinh A, et al. Discontinuing β -lactam treatment after 3 days for patients with CAP (PTC/CAP5). Lancet 2021;397:1195-1203.
- Sociedade Brasileira de Pediatria — Departamento de Pneumologia. Pneumonia adquirida na comunidade na infância (Documento Científico). Diretrizes brasileiras em pneumonia adquirida na comunidade em pediatria – 2007. J Bras Pneumol 2007;33(Supl 1):S31-S50. World Health Organization. Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities. Geneva: WHO, 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde — SRAG/influenza; Protocolo de tratamento de influenza; Calendário Nacional de Vacinação (PNI).
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de pneumonia (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração